

실버톡톡 x 신성델타테크 — 용역 범위 협의 자료

일자: 2026-07-16 | 대상: 신성델타테크 (레미 / Lemmy)

목적: VIP요양병원 PoC 실증 및 개발 용역 범위 구체화

동봉: 그룹웨어 시연 (라이브) · IoT 연동 상세 자료 17p · 기술/규제 조사 3건

1. 한 장 요약

우리 역할	레미가 만든 신호를 요양병원 현장이 실제로 쓰는 것 으로 바꾸는 계층 — 화면·알림·보호자 전달·실증 측정
이미 가진 것	병원용 그룹웨어 25개 화면 개발 완료 (오늘 시연) · 보호자 앱 실서비스 운영 중 (VIP 보호자 실사용) · 파트너 CMS · VIP EMR(브레인) 환자명단 연동 가동 중
그래서	PoC에 필요한 수요처·현장·보호자 채널·화면이 이미 붙어 있다 . 새로 만들 것은 레미와의 접점 이지 시스템 전체가 아니다
오늘 목표	용역 범위 후보(§3)에서 무엇을 발주할지 함께 고르는 것

2. 우리가 이미 운영 중인 것 [사실 — 오늘 시연 가능]

레미 PoC가 필요로 하는 것 중 이미 살아 있는 것:

자산	상태	PoC에서의 역할
보호자 앱 (실버톡톡)	실서비스 — VIP 보호자 실사용 중	실증 성과를 보호자까지 전달하는 유일한 채널 . 신규 구축 불요
병원용 그룹웨어	25개 화면 개발 완료 (오늘 시연)	병동별 실시간 현황·알림 이력·수면 리포트·센서 장비·알림 규칙
파트너 CMS	운영 중	환자·보호자·병실 마스터 관리
환자 명단 연동	가동 중	VIP EMR(브레인 = 핵톤프로젝트)에서 환자·병동·병실·입퇴원 수신
VIP요양병원 관계	운영 파트너	PoC 수요처가 이미 확보된 상태
전자결재 모듈	개발 완료	낙상 알림 → 사고보고서 기안 자동 연계 (오늘 시연 하이라이트)

→ 핵심: PoC의 병목은 보통 "현장을 어디서 구하나 / 보호자에게 어떻게 전달하나"인데, 그 두 개가 이미 해결되어 있다.

3. 용역 범위 후보 — 오늘 함께 고를 것

아래는 제안이다. 레미 사양과 실증 목표에 따라 빼거나 더한다.

#	모듈	내용	우리 상태	난이도
A	센서 연동 계층	레미 → 우리 서버 수집·정규화. 전송 방식(MQTT/Webhook/REST)·주기·과거 데이터 정책	신규 — 레미 사양 확인 후 설계	중
B	병원용 모니터링	실시간 현황·알림 이력·환자별 리포트·장비 상태	화면 완성 → 실데이터 연결	낮음
C	알림·에스컬레이션	규칙 엔진, 미확인 시 승계, 나스콜 연동 , 야간 정책, 무소음 병실	규칙 엔진 설계 완료	중
D	보호자 전달	실버톡톡 앱 연동 + 노출 범위 설계 (§4-3)	앱 운영 중	중
E	★ 실증 성과 측정	지표 정의·자동 수집·리포트 산출 (§4-1)	신규	중
F	★ 규제 대응	웰니스 트랙 문구 정합, 식약처 사전검토 공동 신청 (§4-2)	조사 완료 (870줄)	—
G	환자 마스터 연동	브레인 환자명단 → 센서-환자 매핑	가동 중	낮음

E와 F는 보통 발주서에서 빠진다. 그런데 **PoC의 성패를 실제로 가르는 건 이 둘이다** (§4).

4. 우리가 먼저 말씀드리는 것 — 조사로 확인한 3가지

조사 3건 완료: IoT 모니터링 시장·기술 / 의료기기 인증 인허가 / 요양병원 EMR 연동.

법령 원문·지침서 전문·1차 출처 직접 추출 기반. 상세 자료 동봉.

4-1. ⚠️ 「낙상 감소」를 실증 지표로 잡으면 실패한다 [사실 — 대규모 RCT]

연구	규모	결과
Shorr et al.	27,672명	침대이탈 알람 → 낙상을 유의미한 감소 없음
REFINE	1,839명	동일
Cochrane 리뷰	메타분석	"알람 단독으로는 낙상을 줄이지 못한다"

→ 지표를 「낙상을 감소」로 잡으면, 기술이 잘 작동해도 실증은 실패로 기록된다.

우리 제안 — 실제로 움직이고 증명 가능한 지표:

지표	왜 이것인가
발견 지연 시간 (사건 → 인지)	알람이 실제로 바꾸는 것. 여기서 이긴다
조치 이력 완결성	인증평가·사고 대응의 실물 근거
알림 응답률 / 미확인 에스컬레이션	워크플로우가 도는지
야간 라운딩 효율	인력난 = 사업의 원래 문제의식
보호자 문의 감소	보호자 앱 채널 보유 = 우리만 썰 수 있음

→ 낙상은 「줄이는 것」이 아니라 「놓치지 않는 것」으로 포지셔닝한다. 이게 근거 있는 유일한 주장이다.

4-2. ⚠️ 의료기기 인증 — 받는 쪽이 손해다 [사실 — 법령·고시 원문]

결론: 웰니스(비의료기기) 트랙 유지를 권고한다.

	2등급을 따면 얻는 것
요양병원 수가	❌ 일당정액수가라 별도 수가 없음
인증평가 가점	❌ 해당 지표가 부존재
복지용구 등재	❌ 허가증이 요건이 아님 (고시 전문에 "허가증" 0건)
정부사업 요구	❌ 복지부 응급안전안심 규격서 219p에 "의료기기" 0회

비용은 40배(300~450만 → 수천만~1.5억), 기간은 10배.

⚠️ 다만 경계선이 「질병명」이 아니라 「위급상황 탐지」에 있다 — 2026.2.12 개정 웰니스 판단기준(지침서-0091-03) 원문:

위해도 판단요소: "심정지, 사망 등 위급한 상황을 탐지하는지 여부"
고위해도 예시: "수면 시 무호흡 등의 측정 기능이 있는 수면평가장치"

→ 제품 문구·기능 정의를 양사가 맞춰야 한다. 우리는 이미 화면 라벨 전체를 관측 사실 진술로 교체했다 (호흡 저하 → 호흡수 기준 미만).

✅ 제안: 「의료기기 해당 여부 검토」 공동 신청 — 무료·10일 회신, 식약처 ☎043-719-3758. 마케팅 문구 확정 전에 사용목적 2~3안으로 등급 민감도를 확인한다.

+ 기획: 복지용구 「낙상알림시스템」 급여 신설 (고시 시행 2026.1.20, 배회감지기와 동렬). 1호 등재 기회 — 단 재가급여라 요양병원 입원환자와는 별개 채널.

4-3. ⚠ 최대 쟁점 — 보호자 앱에 무엇을 보여줄 것인가

**실시간 바이탈과 미확인 낙상 알림을 보호자에게 그대로 주면,
클레임은 병원이 아니라 「우리 화면」으로 온다.**

- 보호자는 24시간 지켜보지 않는다. 그런데 우리 앱에 뒀다는 사실은 남는다
- 오탐 30%를 전제해야 한다 (§ IoT 자료 6.2 — 벤더 "정확도 95%"와 실환경은 다르다). 오탐이 보호자에게 직행하면 신뢰가 먼저 죽는다
- → 병원 내부용(실시간·원시)과 보호자용(가공·요약·사후)을 분리한다. VIP와도 선택의 필요

5. 범위 확정을 위해 필요한 것

레미 쪽 (오늘 확인) — 상세 26문항은 동봉 자료 §4

	질문	왜 범위가 갈리나
1	고정형 사양 — 레이더인가, 대역(60/70GHz), 출력 항목	호흡·심박·수면단계가 안 나오면 B의 절반이 화면에 띄울 값이 없다
2	낙상 판정 주체 — 레미 엣지인가, 우리 서버인가	A·C의 범위와 책임 소재가 여기서 갈린다
3	전송 방식·주기, 과거 데이터 조회 가능 여부	푸시/폴링에 따라 A 재설계. 과거 API 없으면 우리가 저장 → 인프라 요건 발생
4	나스쿨 드라이 콘택트로만 붙는가	⚠ 그렇다면 상세 데이터가 안 온다 — 점점 신호(있음/없음)뿐. B·E의 전제가 무너진다
5	카메라·마이크 탑재 여부	탑재 시 개인정보 난이도 급상승 — 범위·일정에 직결
6	보유 인증 (KC·전자파·의료기기 여부)	§4-2 트랙 정합

우리 쪽 (확인 완료 / 진행 중)

- ✅ VIP EMR = 브레인, 환자명단 엑셀 연동 가동 중
- ❑ VIP와 보호자 앱 노출 범위 합의 ← §4-3, PoC 설계 전 필수
- ❑ 개인정보 위수탁 구조 (우리는 수탁자) · 국내 리전 요건 — 전자의무기록 고시상 예외 없음

6. 제안하는 다음 단계

순서	내용	시점
1	레미 고정형 사양서·API 문서 수령	미팅 직후
2	실증 지표 합의 (§4-1) — 발주서에 들어가기 전에	1주 내
3	용역 범위·산출물 확정 (§3에서 선택)	2주 내
4	식약처 「해당 여부 검토」 공동 신청 (§4-2) — 무료·10일	문구 확정 전
5	PoC 설계서 (시나리오·기간·대상 병동·측정 방법)	범위 확정 후

한 줄: 화면은 이미 있고, 현장도 보호자 채널도 이미 있다.

오늘 맞출 것은 「레미와의 접점」과 「무엇을 성공으로 부를 것인가」다.